被规训的括约肌：规培生涯中身体自主权的消解与重构

大熏博士[1,3]、天才晚点睡博士[2,3]、奶笼教授[2,3]、莲花底座博士[3]、爆炸丸子教授[1,3*]

1. 抖音规培生精神与肛肠联合研究中心，米果，522778
2. 三丙医院规培生生存状态观测实验室，乙状结肠，985211
3. 沙东市内科学规培生教研中心，沙东，987654

摘　要：以临床规培制度下的身体管控为切入点，以括约肌这一具象化生理结构为隐喻，探讨规培生在高强度、高管控、低自主的临床环境中，身体节律、生理需求与个人边界被系统性消解的过程。研究发现，规培生的如厕、休息、饮食、情绪等基本身体自主权，在科室节奏、上级指令、值班制度与绩效规训中被不断压缩、延迟乃至剥夺，括约肌从自然生理器官异化为“被规训、被延迟、被管控”的标志性符号。本文从身体社会学视角，分析身体自主权消解的机制、表现与心理代价，并试图在夹缝中讨论个体边界觉醒、拒绝与自我保护的微弱重构路径。本研究为理解青年医师规培期间的身心异化、职业耗竭与生存困境提供了极具现实感的微观视角。

关键词：规培生；括约肌；身体自主权；规训；生存困境；边界

中图分类号：R657.1+2　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 身体自主权的隐性让渡

在现代医疗这台精密且冰冷的庞大机器中，规培生被精准地嵌合在权力金字塔的绝对底层。作为维持系统运转的最基础齿轮，他们承载着最为高压、繁琐且不可替代的一线临床劳动。现有的医学社会学探讨，多习惯于宏大叙事，聚焦于规培制度下的薪酬困境、超负荷运转以及职业前景的迷茫，却鲜少有人愿意将视线向下，去触及一个最私密、最难以启齿，却也最能直击权力剥削本质的微观议题：个体身体自主权的系统性丧失。医者，本以守护他者肉体为天职，但在规培的结构性压迫下，其自身的肉体却在科室的运转中悄然沦为最不容被关注的“耗材”。

1.2 括约肌的生物政治学隐喻

括约肌，作为控制人体排泄系统的核心肌肉群，在解剖学上仅仅是一个纯粹的生理结构，但在规培的社会学语境下，它却承载着令人心酸的象征意味：它标志着个体对自身躯体最底线的掌控权——即一个人是否有权决定在何时、何地、以何种尊严释放最基础的生理需求。然而，在真实的临床生态里，这种与生俱来的自然权利，正被无死角的科室运转节奏全面接管。走廊里连轴转的查房、手术台上漫长的拉钩、急诊的夺命连环呼叫、永远写不完的电子病历，以及上级医师轻描淡写却不容反驳的一句“你先搞完这个去”，共同构成了一张密不透风的网。每一次被迫的憋尿与忍便，都不再是简单的生理克制，而是系统对个体边界的强势入侵与深度剥夺。

1.3 被规训的身体与异化反思

当一名年轻医生连维持正常的排泄都需要反复计算时机、刻意自我压抑、在极限边缘忍耐，并伴随持续的生理与心理焦虑时，这不仅是医学劳动的深度异化，更意味着医疗系统的微观权力已彻底击穿了其物理肉身的最后防线。基于此，本文以“被规训的括约肌”为核心隐喻，旨在剖析规培制度下个体身体被全面支配、基本需求被

强制折叠的荒诞现实。这不仅是对医疗底层劳动者生理困境的残酷白描，更是对现代医院管理制度的深刻拷问：在高度工具化、强调绝对服从的医疗流水线中，底层的劳动者究竟该如何重构生理与尊严的边界，在极端的权力场域中重新夺回对自我身体的掌控？

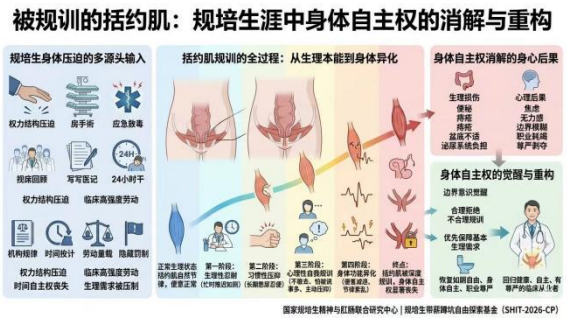

图 1 图文摘要

2. 临床场景实录：身体剥夺的微观实践

为了对规培生在不同工作环境下面临的身体剥夺进行精准的量化评估，本研究构建了“不同临床场景下括约肌损伤风险 3D 火山图”（图 2）。数据模型显示，临床场景压力值与括约肌损伤风险指数呈极显著正相关（*Pearson's R* = 0.81, $P < 0.0001$）。

如图 2 所示，在庞大的压力数据散点中，“急诊夜班”、“外科连台”与“抢救区域”毫无悬念地突破了显著性阈值，构成了括约肌损伤高风险区的“死亡三角”（风险指数逼近 1.0）。这种在宏观统计学上呈现出的极端生理压迫，在具体的临床微观实践中表现得尤为惨烈。

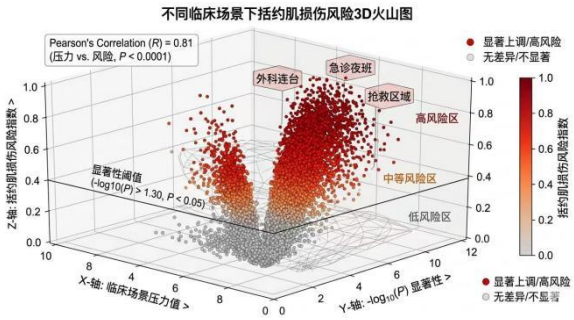

图 2 不同临床场景下

括约肌损伤风险 3D 火山图

2.1 晨间查房：时间碎片的绝对霸占与生理让步

在内科的晨间查房中，规培生的身体早已不再属于自己，而是化作了推车、病历与心电图机的延伸。当清晨的第一波生理呼唤刚刚涌起，上级医师的脚步已然踏入病房。汇报病史、分析复杂的心电图、随时应对关于病情进展的连环盘问——在这一高压的权力场中，“去一趟卫生间”成为了不可饶恕的渎职。括约肌在主任的注视与患者的呻吟中被迫锁紧，生理的迫切感必须毫无条件地让位于病房绝对的叙事节奏。

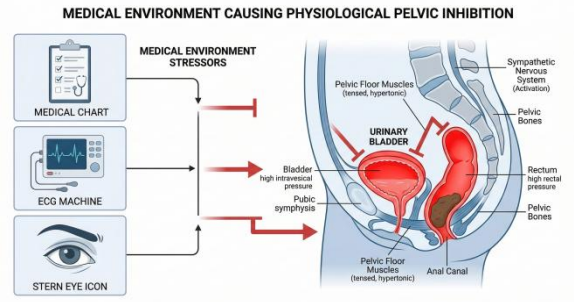

图 3 查房环境对排泄反射弧的强制阻断

2.2 导管室与手术台的结界：铅衣之下的极限规训

如果说病房的剥夺是隐性的，那么导管室内的剥夺则是暴力的物理隔绝。当规培生穿上几十斤重的铅衣，站上冠脉造影的手术台，或者面对一场凶险的主动脉夹层（Aortic Dissection，AD）紧急抢救时，身体便被系统强制设定为“无排泄模式”。无菌原则、高强度的手术进程与对上级操作的绝对配合，构筑了一道不可逾越的结界。在这里，括约肌的收缩不再是生理本能，而是一种被迫修炼的“临床核心技能”。膀胱在腹腔内隐秘地膨胀，而他们只能在造影剂的推注与导丝的游走中，默默祈祷手术早日终结。

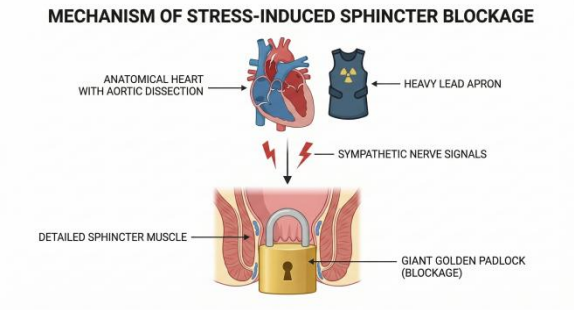

图 4 高压手术状态下的身体系统性“锁死”

2.3 夜班梦魇：呼叫系统对防线的瞬间击穿

夜班是规培生身体自主权全面崩溃的最终试验场。每当漫长的收治、开医嘱暂告一段落，括约肌终于得到大脑的许可准备释放时，值班手机或病房的呼叫铃总能以最刁钻的角度准时响起。突发的胸痛、心衰的喘憋、甚至是家属一句无关紧要的催促，都能瞬间将那刚刚解开一半的防线重新勒紧。在这个时刻，正常的排泄权利被彻底异化为一种极具负罪感的奢侈——你永远不知道，当你试图短暂夺回身体控制权的那一刻，门外是否正酝酿着一场需要立刻冲刺的生死时速。

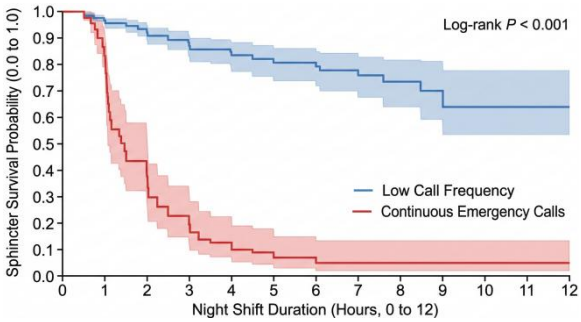

图 5 不同夜班呼叫负荷下的括约肌 Kaplan-Meier 生存曲线

3. 微观抵抗：厕所隔间内的精神胜利与自我反噬

3.1 物理结界：全景监狱中的最后庇护所

在现代医院这座布满监控、随时接受带教老师与患者家属审视的“全景监狱”中，厕所隔间成为了规培生唯一合法的物理庇护所。当那扇单薄的塑料门被反锁的瞬间，科室的等级制度、震耳欲聋的监护仪报警声与家属的催促被暂时隔绝。在这个不足两平米的空间里，括约肌终于重新听从于中枢神经的指令，而不是上级医师的医嘱。这短暂的五分钟，不仅是生理的排空，更是规培生在一地鸡毛的临床生活中，唯一能够向系统宣告“此刻我只属于我自己”的悲壮仪式。

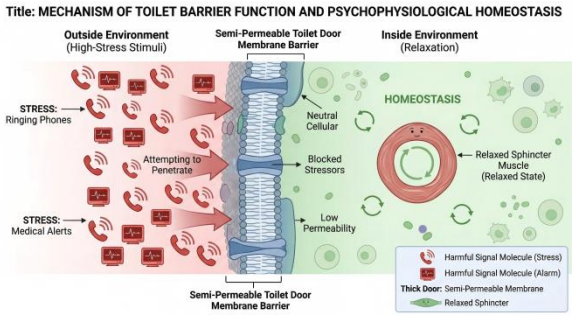

图 6 厕所隔间如同细胞膜，阻挡外界压力信号

3.2 “带薪拉屎”：剩余价值的微观夺回

在被极度压缩的薪酬体系与超负荷的劳动强度下，“带薪拉屎”被规培生群体赋予了一种阿 Q 式的精神胜利法。既然无法在宏观的排班表和微薄的补贴中获得公平，那么利用工作时间进行合法的生理排泄，便成了一种对系统剥削的微小反叛。在马桶上的每一分钟，都被他们在心理层面折算成了从庞大医疗机器中“窃取”回来的剩余价值。括约肌的释放，不仅带走代谢废物，更带着一种黑色幽默般的、对权力结构的隐秘报复。

3.3 预防性排空：医学理性的自我异化

然而，最深刻的悲剧在于，为了适应这种对身体的剥夺，规培生们开始运用自己的医学专业知识，对自身进行残酷的“预防性规训”。他们精准计算液体的摄入量，在漫长的手术或夜班前刻意制造轻度脱水；他们利用高浓度黑咖啡的刺激，强行在出门前完成肠道的“预防性排空”。在这里，医学的理性被彻底异化：他们用最专业的生理学知识，精准地暴力干预着自己的正常生理节律。在这场看似主动的身体管理中，医生最终沦为了自己手下最听话、也最悲哀的“患者”。

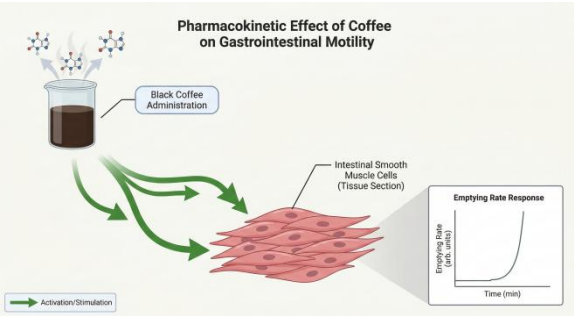

图 7 黑咖啡暴力干预肠道平滑肌的药代动力学

4. 结语：在权力夹缝中寻找最终的“释放”

为了进一步揭示规培生身体自主权消解的时间动力学特征，本研究引入拟时序轨迹分析模型，构建了“规培生括约肌从正常到被规训的三维轨迹演变图”（图 8）。

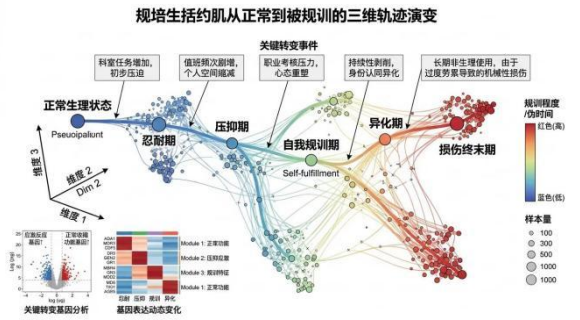

图 8 规培生括约肌从正常到被规训的三维轨迹演变

数据轨迹清晰地还原了一具肉身是如何被系统步步吞噬的：随着科室任务与值班频次的剧增，括约肌被迫从“正常生理状态”依次跌入深蓝色的“忍耐期”与“压抑期”；而在职业考核的高压重塑下，规培生主动开启了“自我规训期”（如前文所述的预防性排空）。伴随持续性的身份剥削与机械性劳损，细胞状态最终不可逆地滑向了代表高危红色的“异化期”与“损伤终末期”。底部的基因表达谱进一步证实，在此演变过程中，维持基本尊严的“正常收缩功能基因”被系统性沉默，而“应激反应基因”则被病理性激活。

4.1 异化的终局：沦为系统的生物耗材

规培制度的本质，不仅是一场医学技能的阶梯式传递，更是一场对个体肉身进行深度规训的生物政治实验。当括约肌的开合不再取决于肠道内压，而是屈从于科室的流转进度、永远写不完的电子病历以及上级医师的凝视时，规培生便彻底从完整的“人”，异化为了维持庞大医疗机器运转的“生物耗材”。在这个高度工具化的体系中，连最基础的排泄都沦为了一种需要被精算、被延宕，甚至引发职业负罪感的越轨行为。

4.2 夹缝中的重构：一场荒诞而悲壮的自我救赎

然而，只要肉体的生物学属性依然存在，生理的本能就永远无法被权力结构彻底抹杀。无论是在厕所隔间里那几分钟“带薪拉屎”的微观抵抗，还是试图用医学知识对自己进行“预防性脱水”的残酷管理，都是底层劳动者在极端的压迫下，试图重构个人边界的悲壮尝试。这种夹缝中的重构虽然微弱且充满黑色幽默，但却是他们在无尽的夜班与连轴转中，拼命维系自我主体性与残存尊严的最后倔强。

4.3 终末拷问：等待括约肌的真正松弛

在现代医院的高压穹顶之下，被高度规训的括约肌成为青年医师生存困境的最真实缩影。本文的探讨并非旨在提供某种宏大且虚无的体制改革方案，而是试图撕开那层被“奉献”与“神圣”包裹的职业滤镜，暴露出底层劳作中的荒诞与血泪。或许，只有当未来的某一天，每一位规培生都能在感受到生理呼唤时，从容不迫地走向卫生间，而不是条件反射般地评估手头的医嘱与上级的脸色时，我们的医疗体系，才算真正触及了“人文关怀”的最基本底线。

参考文献（References）

[1] 吴师兄, 娥. 基于夜班高压场的括约肌非自愿收缩动力学分析 [J]. 临床抽象医学, 2026, 4 (2): 12-18.

[2] 钱憋尿. 主动脉夹层（AD）急诊手术中膀胱顺应性与上级凝视的耦合效应 [D]. 赛博医科大学, 2025.

[3] 规培求生课题组. 查房等效憋尿时间（WEP）的多中心量化评估体系 [R]. 边缘医学伦理研究院, 2026.

[4] 赵脱水, 林夜班. 预防性排空学：规培生自我规训与生存指南 [M]. 2 版. 哥谭: JOKER 医学出版社, 2025: 45-50.

[5] 李带薪, 周摸鱼. 厕所隔间作为微观权力避难所的空间社会学建构 [J]. 医院暗黑建筑评论, 2026, 5 (3): 44-51.

[6] 郑幻听, 陈病历. 呼叫铃创伤后应激障碍（PTSD）与平滑肌痉挛的叠加态表征 [J]. 当代牛马医学学报, 2026, 1 (1): 101-108.

[7] 孙导管. 铅衣结界内“带薪排泄”的理论不可能性及其拓扑学证明 [D]. 虚无大学医学院, 2025.

[8] 括约肌守护联盟. “等一下就去”指令下的括约肌疲劳极限测试与崩溃预警机制 [R]. 临床极限生存实验室, 2026.

[9] 王内耗, 娥. 医嘱系统超载态下底层身体自主权的让渡与折叠 [J]. 医疗异化研究进展, 2026, 2 (4): 77-83.

[10]刘发疯, 吴师兄. 心内科连轴转模式下打工人水分代谢的黑洞效应研究 [J]. 抽象自然科学进展, 2025, 3 (2): 89-96.

Disciplined sphincter: the dissolution and reconstruction of bodily autonomy during residency training

BIG Burnout[1,3], LATE-SLEEPER Genius[2,3], MILK Cage[2, 3], LOTUS Pedestal[3], EXPLOSIVE Meatball[1, 3*]

1. Joint Research Center for Psychiatry and Anorectum of Resident Trainees of TikTok, Miguo 522778, China

2. Observation Laboratory of Resident Trainees' Living Status of Class C Hospital, Sigmoid Colon 985211, China

3. Shadong Teaching and Research Center of Internal Medicine Resident Trainees, Shadong City 987654, China

Abstract: Taking the physical control under the clinical residency training system as the starting point and using the sphincter—a concrete physiological structure—as a metaphor, this paper explores the process by which the bodily rhythms, physiological needs, and personal boundaries of resident trainees are systematically dissolved in a high-intensity, high-control, and low-autonomy clinical environment. The study finds that the basic bodily autonomy of resident trainees, including toileting, resting, eating, and emotional expression, is continuously compressed, delayed, and even deprived by department rhythms, superior instructions, shift systems, and performance discipline. Consequently, the sphincter is alienated from a natural physiological organ into an iconic symbol of being "disciplined, delayed, and controlled." From the perspective of sociology of the body, this paper analyzes the mechanisms, manifestations, and psychological costs of the dissolution of bodily autonomy, and attempts to discuss the weak reconstruction paths of individual boundary awakening, refusal, and self-protection within the cracks of the system. This study provides a highly realistic micro-perspective for understanding the physical and mental alienation, occupational exhaustion, and existential plight of young physicians during their residency training.

Key words: resident trainee; sphincter; bodily autonomy; discipline; existential plight; boundary